

INDICADO POR: Internet

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

GILSON GUARDIA

IDADE: 60 PESO: 90 ALTURA: 175 PROFISSÃO: Cabeleleiro -

SINTOMAS: Tontura / Sonoletargia diurna / congestão e a saliva
Rouca pouco

QUEIXAS: Relatava ruim / mal estar D.L (D e E)

MEDICAMENTOS: Canabidiol / suplemento

MÉDICO: Drº Michel Toledo de Souza

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Musc. (4x) Treina (manhã)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (19h)

HORA QUE DORME: 20 HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILHO ☒ S ☒ N 22/33 DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: ☒ S () N PET NO QUARTO: () S () NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ NFUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: misto BANHEIRO/NOITE: 3X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 37

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: SPO2: 78% / med = 91%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Dor coluna / Ameloro

↓ testosterona / esquecido

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Varizes (cirurgia)

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Apendice

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDIACA Pai e Mãe

() ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS: Roncava

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S (X) N SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

18/08/25 - Avaliação (

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: GILSON GUARDIA

Sexo: Desconhecida

Data do Exame: 07-05-2025

Idade: 59 anos

Peso: 87 kg

Altura: 1,75 m

Médico Solicitante: DR. MICHEL TOLEDO DE SOUZA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 07/05/2025 21:57 e finalizado às 08/05/2025 05:39.

A latência para início do sono foi de **2,0 min** e a latência para o sono REM de **122,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 408,0 min, com eficiência do sono de **88,3 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **1,5 %** de estágio N1, **78,8 %** de estágio N2, **3,9 %** de estágio N3 e **15,8 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 52,1 min. Ocorreram 368 despertares, sendo o índice de **47,8 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 325, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 325 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **47,8 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 34,4 e o IDR durante o sono NREM foi de 50,3. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 47,8 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 47,8 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 94%, a média de 91% e a mínima de 78%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 41,5 (nº/h), sendo que em REM foi de 40,0 (nº/h) e em NREM foi de 48,2 (nº/h). Permaneceu 12,2 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**47,8 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**78%**);
3. Latência para o início do sono (**2,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**122,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**88,3 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares **47,8 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**1,5 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**78,8 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**3,9 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**15,8 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

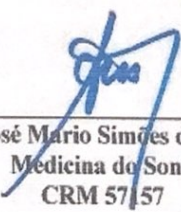
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157